

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT EQUITY LIFE INDONESIA
No. ELI/LGL/___/24
Dengan
PT DISA PRIMA MEDIKA
No :
TENTANG PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN
SECARA BERLANGGANAN**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (**01-11-2024**), telah ditandatangani perjanjian kerja sama pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan secara berlangganan oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini:

1. **Trisnawati Taswin** dan **Tania Chandra**, keduanya berturut-turut selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT Equity Life Indonesia**, berkedudukan di Sahid Sudirman Centre Lt. 43, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tertanggal 5 Desember 1986 dan Akta Perbaikan No. 143 tertanggal 26 Mei 1987, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 15 Juni 1987 No. C2-4266.HT.01.01.TH.87, dan Akta No 18 tertanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. C-5664 HT.01.04.Th.2000 tertanggal 8 Maret 2000, dan Akta No. 7 tertanggal 10 April 2003 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I sebagaimana dalam Surat Keputusannya No. C-08056 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 14 April 2003, serta Akta No. 16 tertanggal 28 April 2006 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 6 Juni 2006 No. C-16402 HT.01.04.TH.2006, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Isyana W. Sadjarwo, S.H., serta perseroan telah menyesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 172 tertanggal 31 Juli 2008, dibuat oleh dan di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tertanggal 29 April 2009, yang dibuat oleh Isyana W. Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM R.I sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 10 Juni 2009 No. AHU-25412.AH.01.02. Tahun 2009, dan susunan Pengurus Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 242 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, di mana pemberitahuan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan diterimanya pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09-0246397 tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

b. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Aprianono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak, secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", dengan ini:

----- **MENERANGKAN** -----

- PIHAK PERTAMA adalah perusahaan asuransi jiwa, dengan ini bermaksud bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi peserta asuransi PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang dengan ini bersedia dan menyatakan sanggup untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dengan segala fasilitasnya untuk memberikan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada peserta asuransi PIHAK PERTAMA.

MAKA, berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah saling bermufakat dan bersetuju untuk dan dengan ini menetapkan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Secara Berlangganan ini, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan **rawat jalan** serta **rawat inap** kepada peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi atau Kartu Tertanggung Asuransi yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. **Kartu Peserta Asuransi** adalah bukti tanda kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang masih berlaku, sebagai bukti yang sah sebagai peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan di rumah sakit PIHAK KEDUA.
 - b. **Kartu Tertanggung Asuransi** adalah bukti tanda kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang masih berlaku, sebagai bukti yang sah sebagai tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan Rawat Inap di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
2. Kartu kepesertaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri:
 - a. **Kartu Peserta Asuransi** yang melalui **proses validasi dan verifikasi AdMedika selanjutnya disebut dengan "proses AdMedika"**, yang berlaku untuk **rawat inap & rawat jalan**, dan kartu kepesertaan yang **tidak melalui proses AdMedika**, yang berlaku **hanya untuk rawat inap**.
 - b. **Kartu Tertanggung Asuransi** yang merupakan Kartu Jaminan Rawat Inap yang melalui proses validasi dan verifikasi AdMedika selanjutnya disebut dengan "**proses AdMedika**", dan hanya berlaku untuk rawat inap.
3. Kelas perawatan dan fasilitas lainnya yang menjadi hak dari peserta asuransi PIHAK PERTAMA tercantum dalam Kartu Peserta Asuransi atau Kartu Tertanggung Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 2
PEMBEBASAN UANG PEMBAYARAN

1. Dengan berlakunya Perjanjian ini, maka Tertanggung/Peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang memerlukan pelayanan pengobatan dan perawatan kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA dengan menunjukkan Kartu Peserta Asuransi atau Kartu Tertanggung Asuransi dibebaskan dari prosedur pembayaran.
2. Pembebasan prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Untuk peserta asuransi** yang menggunakan Kartu Peserta Asuransi yang melalui proses **AdMedika**, maka PIHAK PERTAMA akan **menanggung seluruh biaya baik rawat inap & rawat jalan** yang sesuai dengan batas/limit santunan peserta asuransi yang didapatkan setelah hasil proses AdMedika, dan **biaya yang telah melewati batas/limit** santunan merupakan **tanggung jawab dari peserta asuransi** yang bersangkutan dan untuk itu PIHAK KEDUA secara langsung menagih biaya yang melewati batas/limit santunan tersebut kepada peserta asuransi (pasien) yang bersangkutan;
 - b. Untuk Tertanggung Asuransi yang menggunakan Kartu Tertanggung Asuransi yang melalui proses AdMedika, maka PIHAK PERTAMA akan menanggung seluruh biaya rawat inap yang sesuai dengan batas/limit santunan Tertanggung Asuransi yang didapatkan setelah hasil proses AdMedika, dan biaya yang telah melewati batas/limit santunan merupakan tanggung jawab dari Tertanggung Asuransi yang bersangkutan dan untuk itu PIHAK KEDUA secara langsung menagih biaya yang melewati batas/limit santunan tersebut kepada Tertanggung Asuransi (pasien) yang bersangkutan.
 - c. Untuk peserta asuransi yang tidak melalui proses AdMedika, maka biaya rawat inap yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan biaya rawat jalan sepenuhnya ditanggung secara pribadi oleh peserta asuransi (pasien) yang bersangkutan.
 - d. Untuk Tertanggung Asuransi yang tidak melalui proses AdMedika, maka biaya rawat inap yang timbul sepenuhnya ditanggung secara pribadi oleh Tertanggung Asuransi (pasien) yang bersangkutan.
3. Pembebasan prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) & (2) Pasal ini adalah dengan ketentuan PIHAK KEDUA tidak memberikan pelayanan yang bertentangan dalam Perjanjian ini dan/atau sesuai dengan jumlah santunan yang dimiliki oleh Peserta/Tertanggung asuransi sebagaimana yang terdapat pada data AdMedika.

Pasal 3
FASILITAS YANG DISEDIAKAN

1. Fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah yang sesuai dengan hak peserta asuransi PIHAK PERTAMA yang meliputi:
 - a. **Rawat Inap :**
Dengan atau tanpa tindakan pembedahan
 - b. **Rawat Jalan :**
 - 1) Pemeriksaan dan pengobatan dokter umum/dokter spesialis.
 - 2) Pemeriksaan Laboratorium dan alat diagnostik lain atas indikasi yang tepat sesuai dengan diagnosis
 - 3) Pemberian obat-obatan yang sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
 - 4) Operasi kecil (Bedah Minor) dengan *anesthesi* lokal tanpa penyulit yang tidak memerlukan tindakan rawat inap.
 - c. **Gigi**, pemeriksaan dan pengobatan dokter gigi yang meliputi :
 - 1) Pencabutan gigi tanpa penyulit (*non impacted*).
 - 2) Perawatan syaraf gigi.
 - 3) Tambal gigi dengan amalgam.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

4) Pembersihan karang gigi.

d. Obat-obatan, yang berhubungan dengan perawatan dan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

2. Fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk Tertanggung Asuransi PIHAK PERTAMA meliputi rawat inap.

Pasal 4 **PELAPORAN PASIEN (RAWAT INAP)**

1. Dalam hal peserta asuransi PIHAK PERTAMA memerlukan perawatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan konfirmasi pelaporan Pasien melalui **AdMedika** menggunakan system web yang telah disediakan **AdMedika**.
 - b. PIHAK KEDUA akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap tindakan/pemeriksaan/pengobatan yang memerlukan biaya besar.
 - c. Apabila biaya perawatan/pengobatan peserta asuransi PIHAK PERTAMA baik yang **tidak melalui proses AdMedika ataupun yang melalui proses AdMedika lebih besar atau sama dengan Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan kelipatannya**, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengkonfirmasikan hal tersebut terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA, agar dapat dilakukan pengecekan langsung atas santunan peserta asuransi tersebut.
 - d. Untuk seluruh kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada AdMedika melalui *call center* (24 Jam) dengan **No. (021)- 29603232**.
 - e. Apabila sistem web sebagaimana dimaksud pada poin a di atas mengalami gangguan maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan keluhan melalui Call center Admedika sebagaimana poin d diatas.
2. Dalam hal Tertanggung Asuransi PIHAK PERTAMA memerlukan perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan perawatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA melalui AdMedika dalam tempo selambat-lambatnya 2 x 24 jam dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dan (c) di atas.

Pasal 5 **KONFIRMASI PESERTA ASURANSI (RAWAT INAP)**

1. **PIHAK KEDUA akan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau proses AdMedika pada saat proses AdMedika dilakukan dan PIHAK PERTAMA dan/atau proses AdMedika akan memberikan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA, atas Peserta/ Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan berdasarkan Perjanjian ini dengan mengirimkan dan/atau mencetak "Surat Jaminan Rawat Inap" atau "Surat Penolakan Rawat Inap" (yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini)**
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA dan/atau hasil proses AdMedika mengirimkan dan/atau mencetak "Surat Penolakan Rawat Inap"** kepada PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya perawatan/kesehatan yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA secara pribadi.
3. Dalam kondisi gawat darurat, atau hari libur, maka **"Surat Jaminan Rawat Inap" untuk Peserta/ Tertanggung yang tidak melalui proses AdMedika akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam tempo 1 x 24 jam.**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

4. Dalam kondisi proses AdMedika tidak bisa dilakukan/didapatkan (*off line*), maka **"Surat Jaminan Rawat Inap" untuk Peserta/ Tertanggung yang melalui proses AdMedika**, akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam tempo 1 x 24 jam.
5. Dalam hal Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA yang **tidak melalui proses AdMedika** menjalani perawatan diwajibkan menandatangani **"Surat Pernyataan "** yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA di tempat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyertakannya dalam penagihan pada PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya perawatan sesuai dengan kelas yang menjadi hak yang bersangkutan, dan **untuk Peserta/ Tertanggung yang melalui proses AdMedika** maka selisih biaya ditanggung oleh Peserta/ Tertanggung yang bersangkutan.

Pasal 6 PERAWATAN (RAWAT INAP) & PEMERIKSAAN/PENGobatan DI RUMAH SAKIT LAIN

1. Apabila Peserta/ Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA memerlukan rawat inap, akan tetapi tempat tidur di Rumah Sakit PIHAK KEDUA dalam keadaan penuh, maka PIHAK KEDUA akan mengirim/merujuk (rujuk lepas) ke Rumah Sakit lain di wilayah Jawa Timur dan lainnya.
2. Apabila kamar penuh atau tidak tersedia dan pasien tidak mungkin untuk dirujuk karena kondisinya, maka peserta asuransi boleh menempati kelas kamar perawatan satu tingkat lebih tinggi atau lebih rendah dan selisih akan di-*cover* dahulu oleh PIHAK PERTAMA. Apabila kamar telah tersedia namun peserta tidak mau pindah maka selisih harus dibayar pasien di tempat. **Bahwa ketentuan pada ayat (2) ini tidak berlaku untuk Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA yang menjalani rawat inap, PIHAK PERTAMA hanya menanggung biaya perawatan sesuai dengan haknya Tertanggung Asuransi, dan untuk kekurangan/selisih biayanya merupakan kewajiban Tertanggung Asuransi PIHAK PERTAMA secara pribadi dan wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA sebelum Tertanggung Asuransi PIHAK PERTAMA meninggalkan Rumah Sakit.**
3. Apabila dianggap perlu dan dengan pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan pasien, dokter yang merawat dapat merujuk peserta asuransi PIHAK PERTAMA ke Rumah Sakit lain di wilayah lainnya, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan kemudian dirawat kembali di Rumah Sakit PIHAK KEDUA
4. Biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan atau pengobatan di Rumah Sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan melalui PIHAK KEDUA kepada Rumah Sakit tersebut.

Pasal 7 BIAYA PELAYANAN

- a. Daftar Tarif **Rawat Inap** dan **Rawat Jalan** adalah sebagai berikut :
 - 1.1. a. Tarif fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi peserta PIHAK PERTAMA adalah yang berlaku pada Rumah Sakit PIHAK KEDUA (daftar tarif terlampir).
 - b. apabila terjadi perubahan tarif, maka PIHAK KEDUA akan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum perubahan berlaku secara efektif, dan;
 - c. **apabila perubahan tarif sebagaimana pada poin b diatas tidak diberitahukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka tagihan peserta Asuransi yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA akan mengikuti daftar tarif yang berlaku sebelumnya.**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- 1.2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan fasilitas yang ditetapkan dalam Surat Pengantar dari tagihan PIHAK KEDUA atau Kartu Peserta Asuransi atau Kartu Tertanggung yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.
 - 1.3. Apabila ada permintaan dari Peserta PIHAK PERTAMA untuk dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka tambahan biaya ditanggung oleh peserta PIHAK PERTAMA yang bersangkutan secara pribadi sebelum meninggalkan Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA.
 - 1.4. Dalam hal kelas/kamar yang menjadi hak peserta PIHAK PERTAMA tidak tersedia/penuh, maka PIHAK KEDUA akan menempatkan peserta PIHAK PERTAMA dalam kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi atau lebih rendah dari kelas/kamar yang menjadi hak peserta, dan apabila kelas/kamar yang merupakan hak peserta sudah tersedia maka PIHAK KEDUA secepatnya memindahkan peserta ke kelas yang menjadi hak peserta. Selisih biaya di kelas perawatan yang lebih tinggi tersebut ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA membebankan biaya administrasi pada setiap total tagihan biaya pelayanan Kesehatan Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA sesuai dengan buku tarif PIHAK KEDUA

Pasal 8 KETENTUAN PELAYANAN MEDIS

PIHAK KEDUA dalam hal memberikan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan wajib memenuhi ketentuan pelayanan medis yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:

1. Memperhatikan **Daftar Pengecualian** yang tercantum pada bagian Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pemberian obat-obatan harus selalu berpedoman pada Daftar Obat Generik dan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

Pasal 9 TATA CARA PELAYANAN MEDIS

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan dan/atau pengobatan PIHAK KEDUA harus meminta Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA untuk:
 - a. Memberikan Kartu Peserta/ Kartu Tertanggung Asuransi yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA atas nama yang bersangkutan yang masih berlaku, **guna proses AdMedika dan pemeriksaan dan/atau pengobatan dapat dilakukan**;
 - b. Setelah proses AdMedika dan pemeriksaan dan/atau pengobatan dilakukan maka selanjutnya adalah proses sistem AdMedika yang hasilnya adalah **Surat Pengesahan & Tagihan** yang tercetak dari Sistem AdMedika;
 - c. **Dalam keadaan proses validasi AdMedika tidak bisa dilakukan/didapatkan (off line)**, maka PIHAK KEDUA harus melakukan konfirmasi ke PIHAK PERTAMA melalui *call center* (24 Jam) dengan **No.(021)- 29603232** (untuk Peserta Asuransi), atau PIHAK KEDUA harus melakukan konfirmasi ke PIHAK PERTAMA melalui AdMedika dengan menyebutkan Identitas Tertanggung Asuransi tersebut (untuk Tertanggung Asuransi).
2. Sebelum dilakukan pemeriksaan dan/atau pengobatan PIHAK KEDUA harus meminta Tertanggung Asuransi PIHAK PERTAMA untuk:
 - a. Memberikan Kartu Tertanggung Asuransi yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA atas nama yang bersangkutan yang masih berlaku, guna proses AdMedika dan pemeriksaan dan/atau pengobatan dapat dilakukan;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- b. Setelah proses AdMedika dan pemeriksaan dan/atau pengobatan dilakukan maka selanjutnya adalah proses sistem AdMedika yang hasilnya adalah Surat Pengesahan & Tagihan yang tercetak dari Sistem AdMedika;
 - c. Dalam keadaan proses validasi AdMedika tidak bisa dilakukan/ didapatkan (*off line*), maka PIHAK KEDUA harus melakukan konfirmasi ke PIHAK PERTAMA melalui AdMedika dengan menyebutkan Identitas Tertanggung Asuransi tersebut.
2. Setelah dilakukan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengobatan, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan Kartu Peserta Asuransi/ Kartu Tertanggung Asuransi atas nama yang bersangkutan kepada pasien.

Pasal 10

TATA CARA PENGAJUAN PENAGIHAN

Kuitansi penagihan biaya pelayanan pemeriksaan dan/atau pengobatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. **Rawat Jalan & Rawat Inap :**
 - 1.1. Rekap pengajuan penagihan dan perincian biaya per pasien dengan melampirkan slip hasil validasi AdMedika.
 - 1.2. Fotokopi Kartu Peserta Asuransi/Kartu Tertanggung Asuransi yang bersangkutan
 - 1.3. Kuitansi pemeriksaan dokter umum/spesialis harus disertai dengan :
 - Formulir Perawatan Medis yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang telah diisi lengkap dan jelas oleh dokter yang memeriksa;
 - 1.4. Kuitansi pengambilan obat di Apotek/Rumah Sakit.
 - 1.5. Kuitansi pemeriksaan Laboratorium yang harus disertai dengan:
 - Fotokopi surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan tersebut;
 - Kuitansi dari Laboratorium beserta perinciannya;
 - Fotokopi hasil pemeriksaan tersebut.
2. **Tindakan Pemeriksaan & Pengobatan Akibat Kecelakaan:**
 - 2.1. Rekap pengajuan penagihan dan perincian biaya per pasien.
 - 2.2. Fotokopi Kartu Peserta Asuransi/ Kartu Tertanggung Asuransi yang bersangkutan.
 - 2.3. Keterangan medis termasuk diagnosis dan terapi yang dilakukan dari dokter yang mengobati dengan mengisi Formulir Perawatan Medis yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PENAGIHAN

Jangka waktu penagihan biaya pemeriksaan dan/atau pengobatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maksimal adalah **1 (satu) bulan** setelah tanggal pelayanan pemeriksaan dan/atau pengobatan Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA atau setelah lepas perawatan rawat inap dari Rumah Sakit PIHAK KEDUA, di luar batas waktu tersebut biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak dapat ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA ataupun peserta asuransi PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

WAKTU PELAYANAN

PIHAK KEDUA melaksanakan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 13
CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA secara berkala akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA, yang harus dilunasi sepenuhnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sejak tagihan tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap.
2. Setiap pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui *transfer*/pemindahbukuan pada rekening Bank PIHAK KEDUA, Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kesehatan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIJJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO:

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 144-0055533324
Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang : KK Malang - Blimbing
Kode SWIFT/IBAN : BMRIIDJA

Pasal 14
TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin bahwa pelayanan dan/atau perawatan medis yang diberikan kepada Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA adalah:
 - 1.1. Konsisten dengan diagnosis dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan pelayanan rawat inap & rawat jalan.
 - 1.2. Sesuai dengan standard praktisi medis yang berlaku (Kementerian Kesehatan R.I.).
 - 1.3. Tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA atau oknum PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan dari limit santunan, seperti namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:
 - 2.1. Permintaan Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA untuk mengubah tanggal pemeriksaan dan/atau perawatan ataupun diagnosis penyakit.
 - 2.2. Permintaan pelayanan medis seperti pemeriksaan Laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis.
 - 2.3. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit santunan untuk pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Peserta Asuransi/Kartu Tertanggung Asuransi PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib mengajukan tagihan sesuai dengan Daftar Tarif sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini, beserta perubahannya yang telah disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Apabila tagihan yang diajukan tidak sesuai dengan Daftar Tarif yang telah disampaikan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan tagihan sesuai dengan Daftar Tarif yang telah disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib memperhatikan Daftar Pengecualian yang tercantum pada bagian Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

5. Dalam hal PIHAK PERTAMA membutuhkan laporan medis Peserta/ Tertanggung asuransinya dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menjamin bahwa telah memiliki otorisasi dari Peserta/Tertanggung asuransinya untuk memperoleh laporan medisnya dari PIHAK KEDUA dan membebaskan PIHAK KEDUA dari gugatan pasien dan atau keluarga pasien, dengan ketentuan adanya surat pernyataan pemberian kuasa yang harus ditandatangani dan disahkan oleh Peserta/Tertanggung atau keluarga Peserta/Tertanggung.
6. Apabila terdapat perbedaan tarif antara yang ditagihkan dengan daftar tarif terlampir maka selisih tagihan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, wajib dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA terkait terdapatnya selisih tagihan.
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA yang pertama kali diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dituangkan/dinyatakan oleh PIHAK KEDUA dalam Formulir Perawatan Medis setelah pasien meninggalkan Rumah Sakit, serta PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA atau pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian Formulir Perawatan Medis.
8. PIHAK KEDUA berkewajiban mengetahui jumlah biaya santunan Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA **baik untuk rawat jalan maupun rawat inap, (untuk peserta yang melalui proses AdMedika)** yang ada pada hasil AdMedika, dan untuk itu apabila terjadi kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya perawatan/pengobatan yang telah dilakukan, **dan/atau terdapat biaya yang tidak mendapat penggantian dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib secara langsung menagih atas kekurangan biaya tersebut kepada Peserta/Tertanggung asuransi (pasien) sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit PIHAK KEDUA.**
9. Dalam hal Tindakan operasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta Asuransi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan Perkiraan Biaya Operasi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan indikasi medis secara wajar dan akurat. Biaya akhir yang ditagihkan dari Tindakan operasi tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh lima persen) dari perkiraan biaya operasi yang diberikan serta sesuai dengan Daftar Tarif yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Apabila biaya akhir dari tindakan tersebut melebihi 50% dari Perkiraan Biaya Operasi maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 15 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu **5 (Lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. Jika setelah berakhirnya jangka waktu tersebut tidak ada perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat jangka waktu tersebut diperpanjang secara otomatis.
2. Pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian ini atau mengadakan perubahan-perubahan berkewajiban menyampaikan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian atau tanggal dimulainya perubahan-perubahan yang dikehendaki.
3. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini mengenai pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri apabila terjadi hal-hal berikut ini:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 di atas, jangka waktu mana tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja dan/atau reputasi PIHAK lainnya secara berkala paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi PIHAK lainnya tersebut.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- c. Terjadi wanprestasi oleh salah satu PIHAK.
 - d. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b di atas, maka harus melalui prosedur sebagai berikut:
 - 1) PIHAK yang terkena wanprestasi akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK yang melakukan wanprestasi, peringatan tertulis mana akan merinci jangka waktu bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya.
 - 2) Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, PIHAK yang melakukan wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan maka PIHAK yang terkena wanprestasi berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian.
4. PARA PIHAK sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia sepanjang diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini.
5. Walaupun Perjanjian ini diakhiri, namun tidak melepaskan tanggung jawab PARA PIHAK yang timbul sebelum pembatalan Perjanjian dan pemenuhan atas hak tersebut dapat dituntut sesuai Perjanjian ini.
6. Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah salah satu atau lebih dari kejadian sebagai berikut:
- 1) pelanggaran oleh salah satu PIHAK atau lebih atas kewajibannya atau ketentuan dalam Perjanjian ini dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan dari PIHAK yang tidak melanggar;
 - 2) pernyataan dan/atau jaminan yang diberikan oleh salah satu atau lebih PIHAK dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, baik ketika diberikan maupun sepanjang berlakunya Perjanjian ini;
 - 3) salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang atau pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit;
 - 4) sebagian besar aset milik salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dikenakan suatu sitaan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 16 SANKSI

1. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan kelalaian dalam melaksanakan pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA melebihi dari waktu yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5 % (lima persen).
2. Apabila maksimum denda sebesar 5 % (lima persen) telah terlampaui, maka PIHAK KEDUA dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.I. berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan tetap mewajibkan PIHAK PERTAMA membayar seluruh tagihan-tagihan PIHAK KEDUA berikut dengan dendanya.
3. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk terlebih dahulu memeriksa tagihan-tagihan PIHAK KEDUA akibat pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang telah dilakukan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA kepada Peserta/Tertanggung asuransi PIHAK PERTAMA, apabila terbukti dari hasil analisis dan verifikasi yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA bahwa terdapat pelanggaran ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 14 dan atau terdapat tindakan penyalahgunaan limit santunan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak membayar biaya pelayanan tersebut.
4. Apabila PIHAK KEDUA memberikan pelayanan yang dikecualikan oleh PIHAK PERTAMA seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak membayar biaya pelayanan yang tercantum dalam Daftar Pengecualian.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 17
POTONGAN YANG DIBERIKAN

PIHAK KEDUA akan memberikan potongan 3% (tiga persen) dari besarnya nilai nominal tagihan Rawat Jalan dan Rawat Inap untuk Peserta/Tertanggung asuransi yang akan dipotong langsung oleh PIHAK KEDUA dari total tagihan yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan lebih lanjut yang diatur pada Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 18
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK sepakat mengartikan *force majeure* sebagai suatu keadaan di mana tidaklah suatu perbuatan untuk melaksanakan sebagian dan/atau keseluruhan prestasi dikatakan sebagai wanprestasi (kelalaian) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa luar biasa, berasal dari luar dirinya, dan tak seorangpun dapat menghindari peristiwa dimaksud;
2. Peristiwa-peristiwa luar biasa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* adalah bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami, wabah penyakit tertentu dan bersifat nasional, keadaan perang yang melibatkan Negara Republik Indonesia, huru-hara yang terjadi di dalam negeri, demonstrasi, pemogokkan massal para buruh dan pekerja, adanya wajib militer, kebijakan moneter dalam negeri yang mengakibatkan perekonomian Indonesia tidak berjalan, termasuk di dalamnya terjadi devaluasi, inflasi yang tidak terjadi, dan peristiwa-peristiwa lain yang karena satu dan lain hal berasal dari luar diri PARA PIHAK;
3. Dalam hal salah satu Pihak mengalami kejadian yang termasuk dalam kategori sebagaimana diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) di atas, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak awal terjadi Peristiwa tersebut;
4. PARA PIHAK sepakat jika terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) di atas, akan melakukan penyesuaian kembali kepada keseluruhan isi Perjanjian.

Pasal 19
PEMBERITAHUAN

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA,

PT EQUITY LIFE INDONESIA

Sahid Sudirman Center Lt. 43 Jln. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Telepon : (021) – 80868000

Up : **dr. Hendrikus Dharmawan**

Email : hendrikus.dharmawan@equity.id

Telepon : (021) – 80868000 (Ext 2646)

Up : **dr. William Sonyo**

Email : william.sonyo@equity.id

Informasi Provider, Korespondensi

Telepon : (021) – 80868000 (Ext 2624)

Up : **Asih Putri**

Email : asih.putri@equity.id

Pelaporan Pasien dan Permintaan Surat Jaminan

Telepon : (021) – 29603232

Fax : (021) - 3510886

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Email : customer.care@admedika.co.id
: equity@admedika.co.id

Pengiriman kuitansi penagihan biaya pelayanan pemeriksaan dan/atau pengobatan

PT Adminitrasi Medika Telkom STO Gambir,
Gedung C Lt.1
Jl. Medan Merdeka Selatan No.12
Jakarta Pusat – 10110
Telepon : (021) – 34831100
Fax : (021) – 34830101
Up : Bagian Klaim

2. PIHAK KEDUA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
HP/WA : 0811 3507 164
Email : marketingrsphm@gmail.com

Keuangan : Novi Ratnasari, SE
HP/WA : (0341) 458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Pasuruan
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Telp : 081315574065
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Lidia Emilinda, S.Tr.keb. M.MRS
HP/WA : 081315574065
Email : backupdatamarketingphs@gmail.com

Keuangan : Anita Fitriasisari, S.E
HP/WA : 085156001411
Email : keuanganrsphs@gmail.com

Komunikasi tertulis dianggap telah diterima pada saat (a) diterima sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima jika dikirim dengan pos tercatat atau kurir; (b) keluarnya pemberitahuan pengiriman lengkap jika dikirim melalui faksimili; atau (c) pada saat email tiba di alamat email yang dituju jika dikirimkan melalui email. Jika pemberitahuan dikirimkan melalui faksimili atau email, maka asli pemberitahuan akan dikirimkan melalui pos tercatat. PARA PIHAK akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pihak lainnya apabila ada perubahan terhadap nama wakil, alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau alamat email sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan dengan itikad baik.
2. Jika cara penyelesaian sebagaimana disebut dalam ayat 1 di atas tidak diperoleh kata sepakat setelah bermusyawarah dengan itikad baik selama 30 hari kalender, maka salah satu Pihak berhak untuk mengajukan perselisihan dimaksud ke pengadilan yang berwenang untuk diselesaikan.
3. Untuk kepentingan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap (domisili) di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
4. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

PASAL 21
KERAHASIAAN

1. Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian yang diterima oleh salah satu atau lebih PIHAK dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk akan tetapi tidak terbatas pada data peserta kesehatan, identitas dan hasil pemeriksaan peserta kesehatan, kerja sama yang dilakukan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini beserta dokumen-dokumen/informasi penting lainnya baik lisan tertulis ataupun dalam bentuk lainnya harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data/informasi rahasia tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga atau menggunakan informasi dan data tersebut untuk kepentingan PARA PIHAK yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, kecuali:
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan permintaan pihak yang berwenang atas salah satu PIHAK;
 - c. Berdasarkan perintah pengadilan atau arbitrase.
2. PARA PIHAK wajib memastikan dipatuhinya kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut sehubungan dengan Perjanjian selama Perjanjian berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir atau diakhiri.
3. PARA PIHAK wajib memastikan semua pegawainya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan sehubungan dengan Perjanjian ini.
4. Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan kerahasiaan yang tercantum dalam Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

PASAL 22
PERNYATAAN

PARA PIHAK menyatakan terhadap satu sama lain bahwa PARA PIHAK adalah:

1. perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
2. berwenang dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya;
3. berwenang dan memiliki izin, kemampuan serta kecakapan dan keahlian untuk membuat dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
4. tidak dalam keadaan pailit atau di bawah pengampunan atau terkena keadaan penundaan pembayaran utang;
5. pembuatan dan/atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian lain yang mengikat PIHAK dimaksud;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

6. yang menandatangani Perjanjian ini atas nama PARA PIHAK adalah berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat Para Pihak terhadap Perjanjian ini.

PASAL 23 LAIN-LAIN

1. Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya tanpa persetujuan PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan terjadi karena restrukturisasi internal salah satu PIHAK maka pengalihan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari PIHAK lain dan hanya perlu diberitahukan kepada PIHAK lain sebelum terjadinya pengalihan. Pihak yang menerima pengalihan akan menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini.
2. Perubahan-perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila di kemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah sebagai suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dari PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal di dalam Perjanjian ini dan menggantikan seluruh perjanjian, pengaturan, diskusi, negosiasi, pernyataan dan pemahaman yang ada sebelumnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
4. Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan mengganti ketentuan dimaksud dengan ketentuan baru yang mencerminkan maksud PARA PIHAK.
5. Ketentuan dalam Pasal 20 (Penyelesaian Perselisihan dan Hukum Yang Berlaku), Pasal 21 (Kerahasiaan) dan Pasal 22 (Pernyataan) tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
6. Para Pihak sepakat bahwa seluruh Lampiran, surat dan dokumen-dokumen yang ada atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk Daftar Tarif Rumah Sakit) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PT EQUITY LIFE INDONESIA**

**PIHAK KEDUA,
PT DISA PRIMA MEDIKA**

Trisnawati Taswin
Wakil Presiden Direktur

Tania Chandra
Direktur

Endang Susilowati
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Lampiran I
Tentang
DAFTAR PENGECUALIAN

Hal-hal yang tidak ditanggung di dalam polis adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dan/atau perlengkapan :
 - Yang tidak diperlukan untuk pengobatan suatu penyakit atau cedera (salon, foto bayi, video bayi, biaya akte kelahiran dan lain-lain).
 - Yang bersifat eksperimental dan pengobatan alternatif seperti, tetapi tidak terbatas pada: dukun, sinthe, pijat refleksi, *chiropractic, holistic, naturalis, herbalis, hydrotherapy, hyperbaric*, terapi *ozone*, akupuntur yg bukan dilakukan oleh Dokter Spesialis Akupuntur Medis).
 - Yang semata-mata untuk kenyamanan TERTANGGUNG atau jasa-jasa non medis (telepon, televisi, *telex*, cuci pakaian, *washlap, underpad*, sabun/pembersih, shampoo, tisu, obat kumur, dan lain-lain)
2. Biaya pelayanan dan perlengkapan yang dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)/instansi pemerintah, atau suatu program kesehatan pemerintah atau swasta lainnya, biaya atas jasa yang dibuat oleh anggota keluarga TERTANGGUNG atau oleh seorang yang tinggal dengan TERTANGGUNG, biaya pemeriksaan dan/ atau pengobatan yang sedemikian rupa sehingga biaya tersebut tidak wajar.
3. Operasi dan perawatan untuk tujuan kosmetika, ganti kelamin, penambahan dan pengurangan berat badan (*obesitas, anorexia, bullimia*), tindakan dan peralatan yang berhubungan dengan *Hemodialisis* (cuci darah), transplantasi organ tubuh (biaya yang terjadi akibat pengadaan organ tubuh/biaya yang terjadi sebagai donor organ tubuh), Alat pacu Jantung, Alat Proteza, Alat Fisioterapi, termometer digital dan Alat bantu atau sejenisnya (*Hearing Aids, Crurk/tongkat*), alat koreksi buatan atau bahan sintesis baik yang di luar atau melekat pada tubuh, perawatan khusus (*rest cures, custodial care*), dan perawatan yang semata-mata hanya untuk membantu seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
4. Pengobatan terhadap penyakit bawaan (*Congenital*), kelainan tumbuh kembang (*Down syndrome, autisme, Failure To Thrive, speech delay*, gangguan perkembangan alat kelamin dan lain-lain), khitan dengan alasan apapun, perawatan/pengobatan untuk gangguan fisik dan mental termasuk fisiologis (menopause/andropause dan penyakit *geriatric*) atau manifestasi penyakit kejiwaan (psikosomatik), *stress*, lelah mental, susah tidur/insomnia, *neurosis, psikosis, fatigue*, disfungsi seksual dan lain-lain, pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin yang ditularkan secara langsung maupun tidak langsung, serta akibat yang ditimbulkannya, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*).
5. Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan penggunaan alkohol, NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif), atau obat-obatan lainnya (kecuali akibat dari obat-obatan yang berdasarkan resep dokter dan/atau bertujuan medis), percobaan bunuh diri, cedera yang disengaja, cedera karena percobaan/tindak kejahatan, pelanggaran/perlawanan terhadap hukum, keterbukaan terhadap bahaya.
6. Pembelian obat tanpa resep dokter, pembelian obat di luar Apotek resmi (toko obat), segala jenis vitamin yang dipergunakan bukan untuk suatu penyembuhan, makanan tambahan (*food supplement*), obat-obatan tradisional (jamu), herbal, obat yang mengandung ekstrak herbal, imunisasi, pemeriksaan fisik dan Laboratorium yang tidak dirujuk oleh dokter atau atas permintaan sendiri (termasuk *General Check Up* yg dirujuk oleh dokter).
7. Operasi Lasik, pembelian kaca mata gelap, kaca mata lainnya dan lensa kontak.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

8. Tindakan-tindakan atau perlengkapan yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran, aborsi, sterilisasi, keluarga berencana dan pengobatan untuk mendapatkan kesuburan, termasuk penyakit-penyakit yang timbul akibat keadaan tersebut.
9. **Santunan perawatan Rumah Sakit (rawat inap)** tidak diberikan terhadap semua biaya yang timbul karena perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan langsung dengan gigi (termasuk komplikasinya, operasi/pembedahan mulut), kecuali akibat kecelakaan.
10. Terlibat aktif dalam perang, pemogokan, kerusakan, huru hara, perkelahian, perbuatan kriminal atau aktifitas yang berhubungan dengan teroris.
11. Penyakit atau cedera yang timbul akibat dari Tertanggung mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dari suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam dengan *scuba*, *rafting*, *bungee jumping*, ski air, ski es, tinju, karate, judo, atau olah raga bela diri lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya, perjalanan dengan pesawat terbang atau semacamnya kecuali Tertanggung merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap.
12. a. Penyakit - penyakit di bawah ini mulai dijamin setelah **6 (enam) bulan sejak mulai menjadi Tertanggung (hanya untuk rawat inap):**
 - *Tuberculosis* (TBC) & *Asthma Bronchiale*.
 - Batu/radang Kandung Empedu.
 - Batu/radang pada ginjal, saluran kemih/kandung kemih.
 - Kencing manis (*Diabetes Mellitus*).
 - Tekanan darah tinggi (*Hipertensi*).
 - Ayan (*Epilepsi*).
- b. Penyakit - penyakit di bawah ini mulai dijamin setelah **12 (dua belas) bulan sejak mulai menjadi TERTANGGUNG (hanya untuk Rawat Inap) :**
 - Segala jenis Hernia.
 - *Haemorrhoid* (Wasir) dan kelenjar sekitar anus.
 - Amandel yang memerlukan tindakan operasi.
 - Kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi.
 - Segala jenis tumor jinak/ganas.
 - *Varikokel* atau *hidrokel*, segala jenis gangguan prostat.
 - Segala jenis kelainan telinga, hidung (termasuk rongga sinus) dan tenggorokan.
 - Penyakit jantung dan pembuluh darah, CVD (*Cerebrovascular Disease*).
 - Pembedahan pengangkatan rahim, baik dengan atau tanpa pengangkatan saluran telur atau indung telur.
 - Semua jenis kelainan vertebro spinal (tulang belakang atau sumsum tulang belakang) termasuk kelainan diskus.
 - Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari.
 - Segala bentuk gangguan pada hati (*liver*).
 - Penyakit kelenjar gondok (*thyroid*)
 - Segala jenis kelainan lutut dan rheumatik
 - *Cataract* (kekeruhan lesa mata)
13. Keadaan yang telah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*)
Santunan tidak diberikan untuk pengobatan atau perawatan suatu penyakit atau cedera beserta akibatnya selama 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tertanggung memenuhi persyaratan untuk memperoleh santunan-santunan di dalam POLIS ini, jika penyakit atau cedera tersebut telah ada dan tanda-tanda atau gejalanya disadari maupun tidak disadari oleh Tertanggung sebelum didaftarkan sebagai Tertanggung dalam POLIS ini.
14. Meninggal dunia akibat:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- a. Tindakan bunuh diri.
- b. Terlibat dalam perkelahian, kecuali sebagai pihak yang mempertahankan diri.
- c. Langsung ataupun tidak langsung dari tindakan kejahatan atau penipuan yang dilakukan Tertanggung atau pihak yang berkepentingan dalam POLIS.
- d. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan.
- e. Meninggal akibat penyakit yang tercantum dalam Pengecualian

15. Dalam keadaan *Force Majeure*, yaitu:

Dalam hal terjadi suatu peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap pelaksanaan POLIS ini maka Pihak yang harus memenuhi kewajiban dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan POLIS ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Lampiran II Tentang CONTOH KARTU PESERTA DAN KARTU TERTANGGUNG ASURANSI

1



1. KARTU INI TIDAK DAPAT DIPINDAHTANGANKAN.
2. Simpanlah kartu ini dengan baik, jangan sampai hilang dan rusak.
3. Peserta WAJIB memperlihatkan kartu ini setiap kali berobat.
4. Peserta WAJIB melapor melalui Personalia Perusahaan tempat bekerja, bila ada perubahan data (menikah, melahirkan, meninggal dan kartu hilang atau rusak).
5. Peserta WAJIB menaati peraturan yang ditetapkan PT Equity Life Indonesia.
6. Kartu ini hanya berlaku selama Peserta masih menjadi karyawan perusahaan yang bersangkutan, walau masa berlaku kartu belum berakhir.

Jika kartu ini ditemukan harap kirimkan ke :
Customer Service PT Equity Life Indonesia
Sahid Sudirman Center Lt. 20 JI. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

PT Equity Life Indonesia

Hotline 24 jam
Telp : 021 2960 3232
Fax : 021 3510 886

2



1. KARTU INI TIDAK DAPAT DIPINDAHTANGANKAN.
2. Simpanlah kartu ini dengan baik, jangan sampai hilang dan rusak.
3. Peserta WAJIB memperlihatkan kartu ini setiap kali berobat.
4. Peserta WAJIB melapor melalui Customer Service PT Equity Life Indonesia apabila kartu hilang atau rusak.
5. Tertanggung WAJIB menaati peraturan yang ditetapkan PT Equity Life Indonesia.
6. Kartu ini hanya berlaku selama Peserta masih menjadi karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Jika kartu ini ditemukan harap kirimkan ke :
Customer Service PT Equity Life Indonesia
Sahid Sudirman Center Lt. 20 JI. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

PT Equity Life Indonesia

Help Line Admedika 24 jam
Telp : 021 2960 3232
Fax : 021 3510 886

3



1. KARTU INI TIDAK DAPAT DIPINDAHTANGANKAN.
2. Simpanlah kartu ini dengan baik, jangan sampai hilang dan rusak.
3. Peserta WAJIB memperlihatkan kartu ini setiap kali berobat.
4. Peserta WAJIB melapor melalui Personalia Perusahaan tempat bekerja, bila ada perubahan data (menikah, melahirkan, meninggal dan kartu hilang atau rusak).
5. Peserta WAJIB menaati peraturan yang ditetapkan PT Equity Life Indonesia.
6. Kartu ini hanya berlaku selama Peserta masih menjadi karyawan perusahaan yang bersangkutan, walau masa berlaku kartu belum berakhir.

Jika kartu ini ditemukan harap kirimkan ke :
Customer Service PT Equity Life Indonesia
Sahid Sudirman Center Lt. 20 JI. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

PT Equity Life Indonesia

Help Line Admedika 24 jam
Telp : 021 2960 3232
Fax : 021 3510 886

Full Service Admedika (RI - Show Card)

- Pelaporan pasien masuk dan pulang ke Admedika
- Pelaporan biaya sementara ke Admedika
- Konfirmasi tindakan dan obat-obatan ke Admedika
- Kirim tagihan ke Admedika
- Pembayaran oleh Equity Life Indonesia

Full Service Admedika (RI)

- Pelaporan pasien masuk dan pulang ke Admedika
- Pelaporan biaya sementara ke Admedika
- Konfirmasi tindakan dan obat-obatan ke Admedika
- Kirim tagihan ke Admedika
- Pembayaran oleh Equity Life Indonesia

Full Service Admedika (RI & RJ)

- Pelaporan pasien masuk dan pulang ke Admedika
- Pelaporan biaya sementara ke Admedika
- Konfirmasi tindakan dan obat-obatan ke Admedika
- Kirim tagihan ke Admedika
- Pembayaran oleh Equity Life Indonesia

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

NOTULEN RAPAT EVALUASI PKS EKSTERNAL

HARI / TANGGAL : 06 November 2024
PUKUL : 10.00
JENIS MEETING : Rapat Evaluasi PKS Eksternal
TEMPAT : R. Meeting Sekretariat

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : PKS Lippo General Insurance
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Asuransi membayarkan tagihan sesuai dengan tarif Rumah Sakit b. Selama berjalannya kerjasama tidak ada tagihan yang tertolak c. Terdapat 3 tagihan pasien yang masih belum terbayarkan di tahun 2023 dikarenakan perubahan sistem yang tidak diinformasikan, namun selama tahun 2024 seluruh tagihan di bayarkan tepat waktu d. PIC asuransi responsif dan informatif
	Rencana Tindak Lanjut -
2	Pokok Bahasan : PKS Asuransi Reliance
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Asuransi membayarkan tagihan sesuai dengan tarif Rumah Sakit b. Beberapa tagihan telat dibayarkan oleh pihak asuransi c. Untuk saat ini pembayaran masih berjalan dengan baik d. Asuransi Reliance serung digunakan oleh karyawan Perusahaan, seperti PT Nestle dan PT Charoen Pokphan yang sering rujuk ke rumah sakit
	Rencana Tindak Lanjut - Terkait pembayaran tagihan yang jatuh tempo , pihak rumah sakit akan memberlakukan denda kepada pihak asuransi sesuai dengan isi PKS yaitu 1%
3	Pokok Bahasan : PKS Asuransi Multi Artha Guna
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Terdapat banyak perturan saat melakukan tagihan dan ada 2 kode tagihan yang berbeda pembayaran sehingga terkadang menyulitkan proses penagihan yaitu tagihan melalui admedika atau ke pihak Asuransi b. Hingga saat ini asuransi tidak memiliki piutang kepada Rumah Sakit
	Rencana Tindak Lanjut -
4	Pokok Bahasan : PKS Equity Life Indonesia RI Cashless
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Asuransi membayarkan tagihan sesuai dengan tarif Rumah Sakit b. Selama berjalannya kerjasama tidak ada tagihan yang tertolak c. Pembayaran tepat waktu

	d. Asuransi tidak ada piutang ke Rumah Sakit
	Rencana Tindak Lanjut -
5	Pokok Bahasan : PKS PT Aneka Tuna Indonesia
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Rujukan pasien berjalan baik antara pihak perusahaan dan rumah sakit b. Pembayaran ditanggung oleh BPJS TK dan BPJS Kesehatan tidak ada kendala dalam tagihan pasien c. PIC perusahaan responsif dan informatif
	Rencana Tindak Lanjut -
6	Pokok Bahasan : PKS PT Antarmitra Sembada
	Masalah : Evaluasi Kerjasama
	Keterangan : a. Untuk saat ini belum ada rujukan pasien dari perusahaan ke Rumah sakit b. Perusahaan tidak ada piutang kepada Rumah sakit
	Rencana Tindak Lanjut -

Pemimpin Rapat



(Lidia Emilinda, S.Tr.Keb, M.MRS)

Pasuruan, 05 November 2024

Notulis



(Agistia Zalfa Nasihah, S.M)

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

SUKOREJO



(dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS)

Lampiran I. Dokumentasi

